

TRASTORNOS DEPRESIVOS

Sara Lucía Alzamora Moreno

Maestría en Psicología Clínica





**“HAY BATALLAS QUE SE LIBRAN EN
SILENCIO, PERO PESAN TODOS LOS
DÍAS”**

**–Kay Redfield
Jamison**

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS?

- Son uno de los problemas de salud mental más frecuentes en el mundo.
- Una condición que puede afectar cómo una persona piensa, siente y se relaciona con los demás.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS

- Se caracteriza principalmente por una tristeza constante y por la pérdida de interés o motivación en actividades que antes disfrutaba.
- Puede afectar: relaciones personales, rendimiento, perspectiva de sí mismo



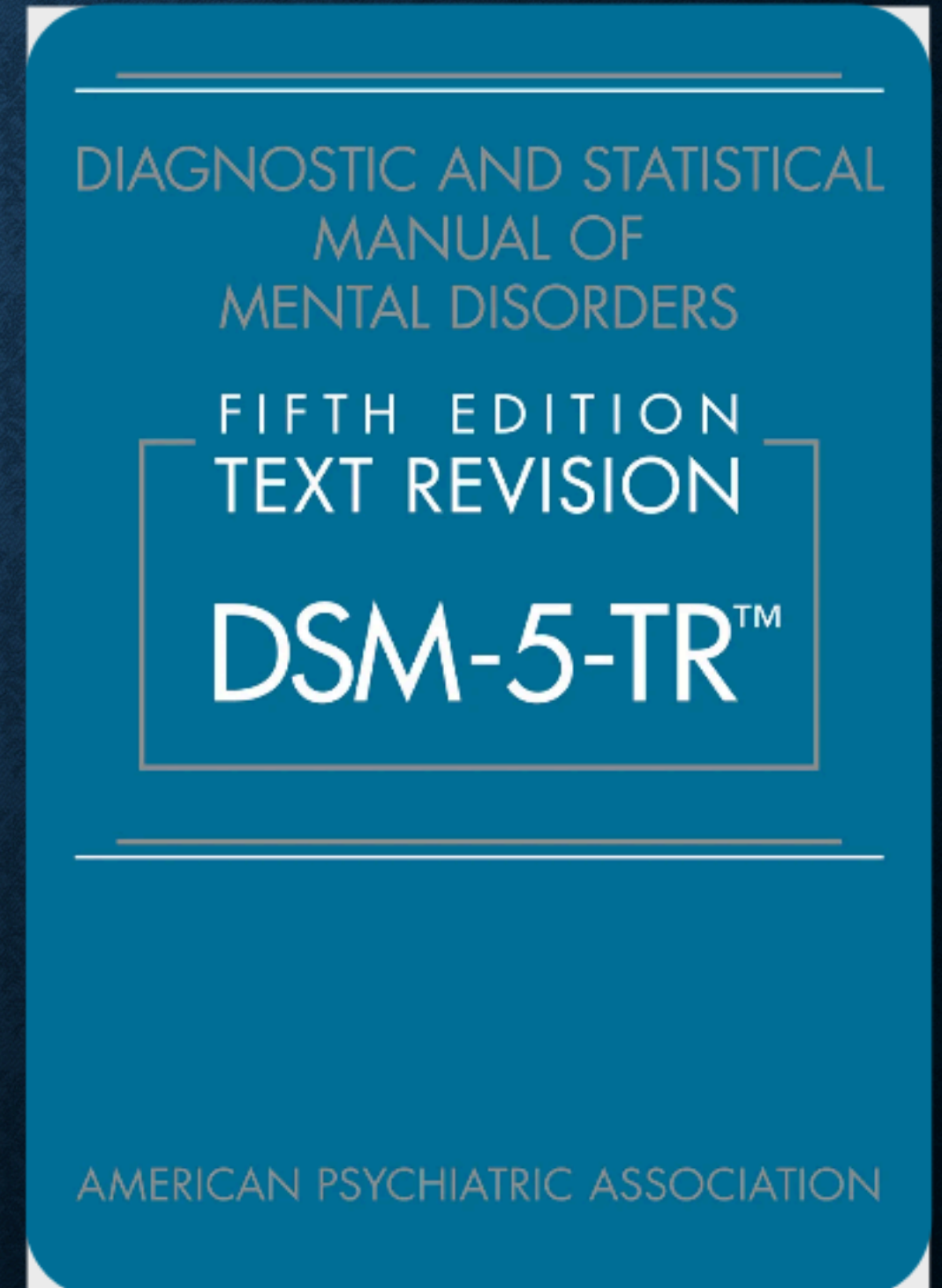
CLASIFICACIÓN DSM-V-TR

- Diferentes tipos como:

Trastorno Depresivo Mayor, Trastorno depresivo persistente,

Trastorno disfórico pre menstrual, etc.

- Se diferencian en tres aspectos



PRINCIPALES TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN EL DSM V – TR

- Trastorno depresivo mayor
 - El más conocido y frecuente.
 - Se caracteriza por episodios de tristeza intensa, pérdida de interés, fatiga, alteraciones del sueño, apetito, concentración y posible ideación suicida.
- Trastorno depresivo persistente (distimia)
 - Depresión más crónica y prolongada.
 - Los síntomas suelen ser menos intensos que en la depresión mayor, pero duran al menos 2 años en adultos.

PRINCIPALES TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN EL DSM V – TR

- Trastorno disfórico premenstrual

Relacionado con el ciclo menstrual.

Produce síntomas emocionales severos antes de la menstruación.

- Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

Diagnóstico principalmente infantil.

Se caracteriza por irritabilidad persistente y explosiones frecuentes de ira.

PRINCIPALES TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN EL DSM V – TR

- Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos
- La depresión aparece por consumo o abstinencia de sustancias o medicamentos.
- Trastorno depresivo debido a otra afección médica
- Los síntomas depresivos son consecuencia directa de una enfermedad médica.

CRITERIOS DX

Trastorno	Enfoque Principal	Síntomas Principales	Duración típica	Comportamiento/rasgo clave
Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo	Irritabilidad crónica grave en niños/adolescentes	Arrebatos de ira frecuentes, enojo persistente, irritabilidad casi diaria	Mayor o igual que de 12 meses	Explosiones desproporcionadas y dificultad para regular emociones
Trastorno depresivo mayor	Episodios intensos de depresión	Tristeza profunda, anhedonia, fatiga, culpa, alteraciones del sueño/apetito, ideación suicida	≥ 2 semanas por episodio	Pérdida marcada del funcionamiento y del interés en actividades
Trastorno depresivo persistente (distimia)	Depresión crónica de larga duración	Estado de ánimo deprimido, baja autoestima, desesperanza, cansancio, problemas de sueño/apetito	≥ 2 años en adultos (≥ 1 año en niños)	La persona suele sentirse “siempre así”
Trastorno disfórico premenstrual	Alteraciones emocionales relacionadas con el ciclo menstrual	Irritabilidad, ansiedad, tristeza, labilidad emocional, fatiga, cambios físicos y de comportamiento	Aparece antes de la menstruación y mejora después	Cambios emocionales severos cíclicos

CRITERIOS DX

Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos	Depresión causada por sustancias o medicamentos	Estado de ánimo deprimido, apatía, alteraciones emocionales asociadas al consumo o abstinencia	Variable; relacionada al uso de la sustancia	Los síntomas aparecen tras consumo, intoxicación o abstinencia
Trastorno depresivo debido a otra afección médica	Depresión secundaria a enfermedad médica	Tristeza, pérdida de energía, apatía, cambios cognitivos o emocionales	Variable según enfermedad	La causa principal es una condición médica identificable
Otro trastorno depresivo especificado	Síntomas depresivos clínicamente significativos que no cumplen criterios completos	Síntomas depresivos variados	Variable	El clínico especifica por qué no cumple criterios completos
Trastorno depresivo no especificado	Presentaciones depresivas incompletas o con poca información	Síntomas depresivos generales	Variable	Se usa cuando no hay suficiente información diagnóstica
Trastorno por duelo prolongado	Duelo persistente e incapacitante tras una pérdida	Añoranza intensa, tristeza persistente, dificultad para aceptar la pérdida, aislamiento	Generalmente > 12 meses en adultos	El duelo interfiere significativamente con la vida diaria

ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025)

Aspecto	Datos estadísticos	Importancia
Prevalencia mundial	Aproximadamente 332 millones de personas padecen depresión, equivalente al 4% de la población mundial .	La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes a nivel global.
Prevalencia en adultos	Aproximadamente 5.7% de los adultos presentan depresión.	Evidencia una alta frecuencia en la población adulta.
Diferencias por sexo	La depresión afecta más a mujeres que a hombres.	Muestra mayor vulnerabilidad en la población femenina.
Relación con suicidio	El suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años .	Refleja la gravedad e impacto de los trastornos depresivos.
Acceso a tratamiento	Muchas personas no reciben tratamiento adecuado, incluso en países con mayores recursos.	Señala limitaciones importantes en los servicios de salud mental.



ESTADÍSTICAS NACIONALES



Organización Panamericana de la Salud (OPS, publicado 2020 – estimaciones 2018)

Aspecto	Datos estadísticos	Importancia
Impacto en salud mental	Los trastornos mentales, neurológicos, por consumo de sustancias y suicidio representan el 18% de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en Panamá.	Constituyen una importante carga para la salud pública nacional.
Discapacidad asociada	Aproximadamente el 34% de los años vividos con discapacidad (AVD) corresponden a trastornos mentales y depresivos.	La depresión genera limitaciones importantes en la vida diaria y funcionamiento social.
Diferencias por sexo	Mayor frecuencia en mujeres.	Coincide con el patrón observado a nivel internacional.
Impacto desde edades jóvenes	Los trastornos depresivos afectan significativamente desde etapas tempranas de la vida.	Resalta la necesidad de prevención e intervención temprana.

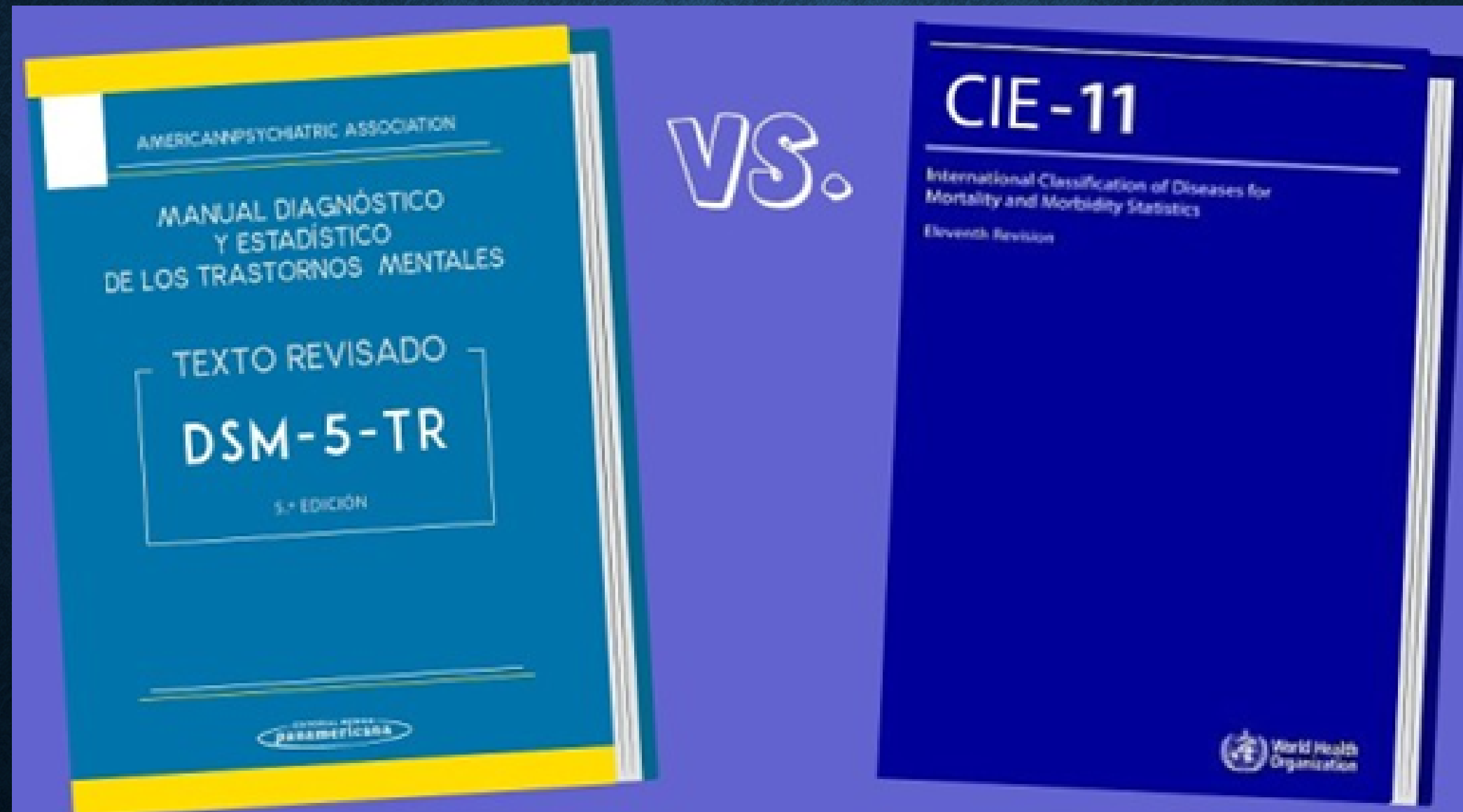
ESTADÍSTICAS NACIONALES

Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA, 2019)

Aspecto	Datos estadísticos	Importancia
Síntomas depresivos en adultos	El 36.6% de la población adulta presenta síntomas de depresión.	Evidencia una alta presencia de síntomas depresivos en Panamá.
Síntomas leves	El 32.3% presenta síntomas leves de depresión.	La mayoría de los casos requieren seguimiento y prevención.
Síntomas moderados a severos	Aproximadamente el 4.3% presenta síntomas moderados o severos.	Representa el grupo con mayor necesidad de atención especializada.
Diferencias por sexo	Los síntomas depresivos son más frecuentes en mujeres.	Coincide con estadísticas nacionales e internacionales.
Necesidad en salud mental	Los resultados muestran la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en Panamá.	Destaca la importancia de mejorar el acceso a diagnóstico y tratamiento.



CUADRO COMPARATIVO



SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Elemento	DSM-5	CIE-11	Similitudes	Diferencias
Enfoque global	Manual diagnóstico con criterios específicos	Sistema de clasificación clínica internacional	_____	El DSM-5 ofrece criterios diagnósticos más estructurados, mientras que el CIE-11 integra la clasificación clínica con mayor flexibilidad para su uso global.
Definición	Trastornos del estado de ánimo con criterios clínicos estructurados	Trastornos del estado de ánimo definidos clínicamente	Coinciden en la definición	_____
Síntomas nucleares	Ánimo depresivo o anhedonia (obligatorio uno)	Ánimo depresivo y/o anhedonia como base	Ambos reconocen ánimo depresivo y anhedonia como centrales	El DSM V exige uno obligatorio, el CIE lo considera central, pero tiene más libertad de decisión
Número de síntomas	Requiere de 5 a 9 síntomas	No exige número fijo	_____	El CIE permite que el profesional evalúe el caso de forma más flexible, sin depender estrictamente de un número fijo de síntomas
Tipo de síntomas	Emocionales, cognitivos y físicos	Emocionales, cognitivos y físicos	Coinciden	_____

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Duración	Mínimo 2 semanas (obligatorio)	Mínimo cercano 2 semanas	Ambos requieren una duración mínima de aproximadamente dos semanas, aunque el DSM-5 lo especifica de forma más explícita.	_____
Deterioro funcional	Requisito obligatorio	Requisito obligatorio	Coinciden	-----
Severidad	Leve, moderado, grave	Leve, moderado, grave		_____
Clasificación	Depresión mayor, persistente, etc.	Episodio depresivo, recurrente, distimia	_____	Ambos sistemas describen cuadros clínicos equivalentes, pero difieren en la forma de organizarlos y denominarlos
Rigurosidad diagnóstica	Más estructurado y estandarizado	Evaluación clínica flexible	_____	Permite al CIE aplicarse mejor en distintos países y sistemas de salud.
Exclusión de causas	Sustancias, enfermedades médicas, bipolaridad	Mismos criterios de exclusión	Ambos descartan causas médicas, sustancias y trastornos bipolar	_____

INVESTIGACIÓN RELACIONADA

[Revista chilena de neuro-psiquiatría](#)

versión On-line ISSN 0717-9227

Rev. chil. neuro-psiquiatr. vol.61 no.3 Santiago 2023

<http://dx.doi.org/10.4067/s0717-92272023000300298>

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Estudio prospectivo descriptivo de las trayectorias de respuesta terapéutica en una cohorte de pacientes con trastorno depresivo mayor

Descriptive prospective study of therapeutic response trajectories in a cohort of patients with major depressive disorder

Camila Vargas^a

Francisca Aguilera^a

Marcelo Arancibia^{a b c}

Rubén Alvarado^d

Fanny Leyton^{c e f g}

^a Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile.

^b Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud (CIESAL), Valparaíso, Chile.

^c Grupo de Investigación en Resiliencia, Adversidad y Reparación (GIRAR)

INVESTIGACIÓN RELACIONADA

A s p e c t o	I n f o r m a c i ó n
T í t u l o d e l a r t í c u l o	E studio prospectivo descriptivo de las trayectorias de respuesta terapéutica en una cohorte de pacientes con trastorno depresivo mayor
A ñ o	2023
P a í s	Chile
L u g a r d e l e s t u d i o	Región de V alparaíso – 7 centros de atención de primaria de salud
H i p ó t e s i s	No plantea una hipótesis explícita, ya que el objetivo principal fue observar las diferentes respuestas al tratamiento en pacientes con trastorno depresivo mayor.
M u e s t r a	159 pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor
T i e m p o d e s e g u i m i e n t o	5 meses
V a r i a b l e i n d e p e n d i e n t e	Tratamiento y seguimiento terapéutico recibido por los pacientes
V a r i a b l e d e p e n d i e n t e	R espuesta terapéutica y evolución de los síntomas depresivos
R e s u l t a d o s	A lgunos pacientes mejoraron, otros permanecieron igual y otros empeoraron durante el seguimiento. Más de un tercio no mostró mejoría significativa.
C o n c l u s i ó n p r i n c i p a l	L a depresión tiene diferentes trayectorias de evolución, por lo que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente.

INVESTIGACIÓN RELACIONADA

- https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272023000300298



FIGURAS PÚBLICAS

Lady
Gaga



Participación en conferencias, foros, impulsando cambios en políticas públicas y programas de apoyo

FIGURAS PÚBLICAS

- Dwayne “La Roca” Johnson
- Enfatiza la importancia de la terapia, apoyo de amigos y familia y el ejercicio



FIGURAS PÚBLICAS



Halle
Berry

Emma
Thompson



VÍDEO



- https://www.youtube.com/watch?v=BwxO_XJN71M

